



UNPAZ
Universidad Nacional de José C. Paz

Informe Diagnóstico de Situación.

- **Equipo 7 - Integrantes:**

- Coronel Tatiana
- Duarte Noelia
- Gauna Braian
- Leiva Patricia

- **Docentes:**

- Funes Gustavo
- Lopez María
- Ortíz Emmanuel
- Rubio Cecilia
- Turín Brenda

Universidad Nacional De José C. Paz

Tecnicatura Universitaria en Informática Aplicada a la Salud

Taller de Proyectos I

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 OBJETIVO GENERAL	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.3 CONTEXTO GENERAL	5
1.4 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	7
2. ANTECEDENTES	8
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	11
3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES “CIRCUITO TRÁNSITO DE PERSONAS EN EL ÁREA DE GUARDIA”	13
3.2 FODA	16
3.3 ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES EN EL REGISTRO VESPERTINO DE MEDICAMENTOS	18
4. CONCLUSIONES	19
5. ANEXO I	21
5.1 ANEXO II	22
6. BIBLIOGRAFÍA	23

1. INTRODUCCIÓN

Somos estudiantes del tercer año de la carrera Universitaria en Informática Aplicada a la Salud de la Universidad Nacional de José C Paz, y en el marco de nuestra formación académica, nos encontramos realizando prácticas en el Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) “Vicente López y Planes”, experiencia que nos permitió acercarnos a la realidad de las instituciones sanitarias y así poder comprender el funcionamiento de sus diferentes áreas y procesos. Como parte de estas prácticas, se llevó a cabo un informe de diagnóstico de situación institucional; el cual constituye una herramienta fundamental para conocer el estado actual de la organización, identificar fortalezas y detectar problemáticas o situaciones de mejora que puedan impactar en la calidad de atención y en el funcionamiento de los diferentes servicios, desde la implementación del Sistema de Historia Integrada de Salud (HSI).

El presente trabajo surge a partir de la observación del funcionamiento cotidiano del servicio de Emergencia (Guardia) hospitalaria y del análisis de los distintos sistemas de información que actualmente coexisten dentro de la institución, entre ellos el Goldberg, Intranet, el HSI; además de los sistemas de los diferentes servicios con el cual cuenta la institución. La convivencia entre estos sistemas dificulta la interoperabilidad técnica y operativa que genera fragmentación de procesos, duplicación de tareas y obstáculos para garantizar una buena circulación de la información clínica.

En este sentido, el *Plan Quinquenal de Salud de la Provincia de Buenos Aires (2023-2027)*¹ plantea que uno de los problemas del sistema es la falta de continuidad entre los niveles de atención, proponiendo una *red integrada* que facilite el recorrido del paciente. Desde esta perspectiva, la Guardia no constituye únicamente un espacio de resolución inmediata de urgencia, sino también un punto estratégico dentro de la red sanitaria para garantizar derivaciones, seguimientos y articulación con otros niveles de atención.

Nuestro diagnóstico busca identificar aspectos organizacionales que influyen en la calidad y capacidad resolutoria del servicio de Emergencia (Guardia), en articulación con los lineamientos establecidos en el Plan Quinquenal, en donde establece como objetivo, fortalecer modelos de atención más integrados,

¹ Ministerio de Salud de la Nación.(2023). *Resumen Ejecutivo: Plan Quinquenal de Salud*.
<https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/wp-content/uploads/sites/244/2023/04/Resumen-Ejecutivo-Plan-Quinquenal-de-Salud.pdf>

protocolizados y orientados a garantizar equidad en el acceso. Para ello, se realizaron entrevistas y observaciones donde se identificaron diversos aspectos relacionados con la integración entre sistemas y la organización de algunos servicios.

Entre las situaciones relevadas se identificó una problemática específica vinculada con el registro en la dispensación vespertina de medicamentos. De acuerdo con el *Manual de Funciones y Procesos para la Implementación de los Cuidados Progresivos en Hospitales Bonaerenses*², resulta fundamental garantizar la trazabilidad y la existencia de un registro único que permita dar continuidad a las indicaciones realizadas en la guardia y así, se complete el seguimiento en el domicilio del paciente. Este aspecto adquiere especial relevancia considerando que el domicilio constituye el primer nivel de cuidados dentro del modelo de cuidados progresivos.

La disponibilidad de los registros completos y accesibles contribuyen a fortalecer la continuidad asistencial y a consolidar los principios de dicho modelo, basado en la articulación entre los distintos niveles y actores involucrados en la atención. En este sentido, el manual establece que “*El paciente debe ser cuidado en red*”; por ello, resulta importante que los procesos de registro y dispensación permitan mantener la continuidad de la información y del acceso a la medicación durante todas las etapas de la atención. Las observaciones realizadas nos permitieron identificar que, en el horario vespertino, existen instancias del proceso que podrían beneficiarse de mecanismos de registro más integrados entre el servicio de la Guardia y de Farmacia.

Este hallazgo se encuentra en concordancia con los lineamientos del Plan Quinquenal de Salud, el cual promueve “*La integración de los niveles de atención y la continuidad del cuidado*” como ejes estratégicos para el fortalecimiento del sistema sanitario. Sin embargo, observamos una fragmentación entre el servicio de Guardia y el de Farmacia en el horario vespertino; la cual limitaría la articulación efectiva entre ambos servicios.

Asimismo, resulta necesario considerar el contexto actual del sistema de salud. Si bien el Plan Quinquenal fue concebido bajo determinadas condiciones de financiamiento de disponibilidad de

² Ministerio de Salud de la Nación.(Noviembre 2025). *Manual de Funciones y Procesos para la Implementación de los Cuidados Progresivos en Hospitales Bonaerenses*.
<https://nc.ms.gba.gov.ar/index.php/s/9CC32jcwW9gJyN3>

recursos, la realidad sanitaria presenta desafíos asociados al desabastecimiento de programas nacionales de provisión, como el *Remediar*³. Estas condiciones impactan en la capacidad de implementación de las estrategias previstas originalmente, lo cual exige adaptar las acciones institucionales para sostener la continuidad de la atención. Esta situación permitió visibilizar limitaciones de carácter organizacional, tecnológico y presupuestario que afectan directamente con la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a recursos esenciales para los pacientes.

Por ello, el presente trabajo no busca únicamente describir una problemática existente, sino comprender sus causas, interpretar sus efectos dentro del funcionamiento institucional y elaborar posibles líneas de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la atención sanitaria. Desde esta perspectiva, se entiende que diagnosticar no implica solamente detectar dificultades, sino generar conocimiento que permita orientar decisiones y acompañar procesos de cambio orientados hacia un sistema de salud más integrado, accesible y centrado en las necesidades de la población.

1.1 Objetivo General

Este informe tiene como objetivo general analizar el funcionamiento del servicio de Emergencia (Guardia) del Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) “Vicente López y Planes” y el proceso de la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), identificando problemáticas relacionadas con la integración de los sistemas de información que conviven actualmente en dicha área, la gobernanza de datos clínicos/administrativos, y los flujos de atención interna entre las diferentes áreas, con el propósito de diseñar una propuesta en las mejoras organizacionales y tecnológicas.

1.2 Objetivos Específicos

Para el desarrollo de este informe se plantea no solo buscar describir la realidad observada, sino también desglosar de manera analítica los componentes humanos, tecnológicos y de los procesos que intervienen en la atención de la Guardia.

³ Ministerio de Salud de la Nación. Programa REMEDIAR: ¿Qué es REMEDIAR? [Argentina.gob.ar.
https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/que-es-remediar](https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/que-es-remediar)

- Caracterizar el circuito de flujo de pacientes dentro del servicio de Emergencias (Guardia), relevando los procesos secuenciales desde la admisión e identificación en ventanilla hasta el egreso definitivo o la transferencia a sectores de internación.
- Identificar los sistemas de información que coexisten en las diferentes áreas del hospital, determinando las barreras técnicas y semánticas de interoperabilidad que limitan su integración con la Historia de Salud Integrada (HSI).
- Evaluar los nodos críticos en la gestión de datos clínicos y administrativos, analizando el impacto que las dificultades de registro y la duplicidad de carga tienen sobre la calidad y la circulación de la información institucional.
- Describir el circuito logístico de gestión y dispensación de medicamentos en la Guardia, con especial énfasis en la cobertura de tratamientos vespertinos para patologías prioritarias, tales como las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB).
- Formular lineamientos estratégicos y recomendaciones tecnológicas que promuevan la continuidad asistencial, la optimización de los recursos y la integración efectiva de los servicios hospitalarios.

1.3 Contexto General

El *Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A.) "Vicente López y Planes"*⁴, situado en la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tiene una extensa trayectoria dentro del sistema de salud pública provincial. Fue inaugurado el 3 de mayo de 1916 como un sanatorio destinado al tratamiento de la tuberculosis. A lo largo de sus 110 años de historia, la institución experimentó diversas transformaciones que acompañaron la evolución de las necesidades sanitarias de la población, pasando de ser un establecimiento especializado a convertirse en Hospital General en 1970 y alcanzando, posteriormente, la categoría de Hospital Interzonal de Agudos en 1992.

⁴ Hospital Interzonal General de Agudos "Vicente López y Planes". (s.f.). *Reseña Institucional e Historia*. Ministerio de Salud de la Nación. <https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hvicentelopezplanes/institucional/historia/>

Actualmente, constituye un hospital provincial de referencia para la *Región Sanitaria VII*⁵, integrada por diez municipios con características demográficas y realidades socioeconómicas heterogéneas. En este contexto, la institución enfrenta el desafío permanente de brindar atención de mediana y alta complejidad a una población con una importante demanda de servicios de salud. Como establecimiento asistencial de segundo nivel organizado en red, dispone de múltiples especialidades médicas y servicios que, en numerosas ocasiones, no se encuentran disponibles en los efectores cercanos, lo que refuerza su papel estratégico dentro de los circuitos de referencia y contrarreferencia regionales.

En la actualidad, el hospital se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional orientado a adecuarse a los lineamientos establecidos por el Plan Quinquenal y al modelo de Cuidados Progresivos promovido por el Ministerio de Salud. Este proceso implica modificaciones tanto en la estructura organizacional como en la conformación de los equipos de trabajo y en las modalidades de funcionamiento de los distintos servicios.

La institución presenta una configuración edilicia compleja, caracterizada por un sistema de pabellones independientes distribuidos en todo el predio y sin conexiones internas entre sí. Esta disposición genera diversas dificultades operativas en los procesos asistenciales, que abarcan desde el traslado de pacientes a través de calles internas hasta la dispersión de los servicios, situación que dificulta la implementación integral del modelo de Cuidados Progresivos, el cual requiere una mayor articulación entre las diferentes áreas de atención.

A esta fragmentación física se suma la coexistencia de diversos sistemas informáticos que no poseen interoperabilidad entre sí, junto con limitaciones vinculadas a la conectividad institucional. Estas condiciones han representado obstáculos para la implementación completa de la Historia de Salud Integrada (HSI) en todos los sectores del hospital.

Por otra parte hubo un cambio de paradigma en la dirección asociada de la institución, pasando de ser un Modelo Médico Hegemónico, caracterizado por ser biologicista, individual y medicalizado, tratando la salud como un bien de consumo y relegando los determinantes de salud; a uno Integral, el cual debe ser integrado, equitativo, participativo y garante de derecho más centrado en los

⁵ Ministerio de Salud de la Nación (2022). *Mapa de la región sanitaria VII*:
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Info_salud/mapas/Accesos/03-RegionSanitaria-Partidos/RS_VII_A3_2022.pdf

determinantes de salud. Frente a este escenario, el equipo directivo definió como estrategia inicial comenzar la implementación de la HSI en el área ambulatoria de la Guardia, entendida como la principal puerta de ingreso de los pacientes al sistema de salud. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 se llevaron a cabo las capacitaciones correspondientes, mientras que la utilización efectiva del sistema se inició en marzo de 2025. La incorporación de la herramienta continúa desarrollándose de manera gradual y progresiva, por lo que su adopción total requerirá un período de adaptación institucional. Debido a que la HSI aún no se encuentra implementada en los consultorios externos, el proceso debió realizarse en un orden inverso al que habitualmente se observa en otras instituciones sanitarias.

El avance de la implementación de la HSI puede observarse actualmente en el sector de Guardia, cuya organización se encuentra reflejada en el organigrama correspondiente. En contraste, las áreas de internación continúan utilizando el sistema Goldberg, además del sistema de Intranet y los registros en soporte papel para la gestión de la información clínica.

1.4 Organización Institucional

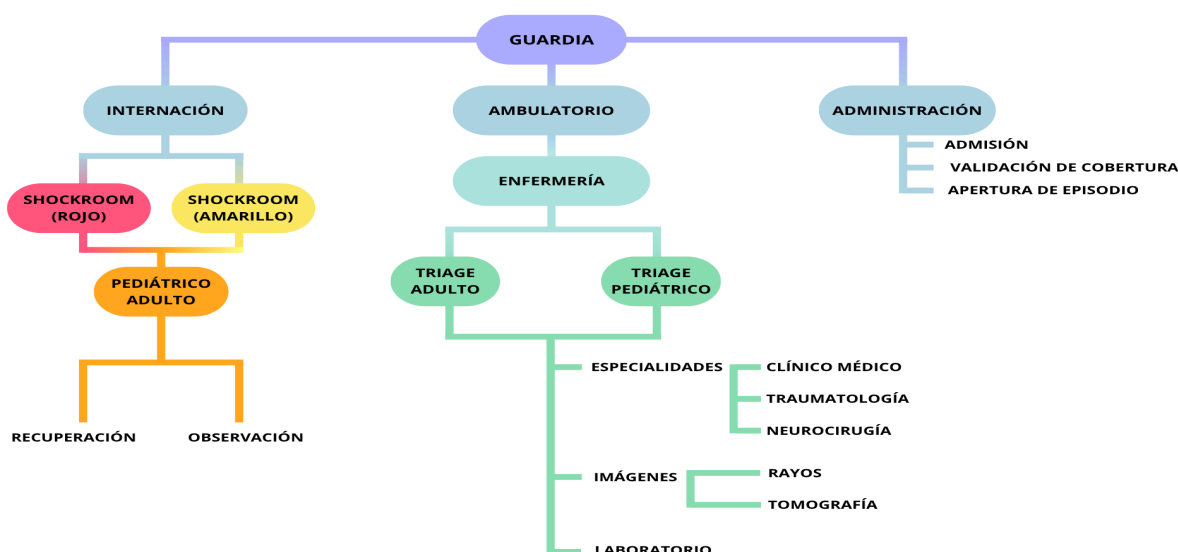
El Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) “Vicente López y Planes” posee una estructura organizativa encabezada por la Dirección Hospitalaria y la Dirección Asociada, de las cuales dependen diversas áreas asistenciales y administrativas. Entre los principales servicios se encuentran la Guardia, los Consultorios Externos, Internación, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Diagnóstico por Imágenes, Enfermería, Farmacia, Laboratorio, Estadística; entre otros servicios y sectores. A su vez, el hospital cuenta con sectores de apoyo vinculados a la administración, facturación y sistemas informáticos, que cumplen un rol fundamental en la gestión de la información y en el funcionamiento general de la institución.

Dentro de esta estructura, el sector Guardia constituye una de las áreas más complejas debido a la necesidad de brindar atención continua durante las veinticuatro horas del día. Su organización incluye funciones administrativas relacionadas con la admisión de pacientes, la validación de cobertura y la apertura de episodios clínicos. También participan profesionales de enfermería encargados del triage, la observación y la realización de procedimientos, además de médicos pertenecientes a distintas

especialidades, entre ellas clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia. El funcionamiento de la guardia se complementa con otras áreas, como laboratorio y diagnóstico por imágenes.⁶ El hospital no solo brinda atención a la población residente en su área programática, sino que también recibe una proporción significativa de pacientes provenientes de localidades vecinas, otros municipios y hasta de otras provincias. Esta situación amplía la demanda asistencial y posiciona al establecimiento como un centro de referencia para diversas consultas y prestaciones de salud.

ORGANIGRAMA DE GUARDIA

H.I.G.A VICENTE LÓPEZ Y PLANES



2. ANTECEDENTES

La incorporación de tecnologías de la información en los servicios de salud ha impulsado transformaciones significativas en los procesos asistenciales y administrativos de las instituciones sanitarias. *La integración consiste en conectar sistemas que tradicionalmente funcionaban de manera aislada: prescripción médica, validación farmacéutica, preparación, dispensación automatizada,*

⁶ Véase Anexo I: “Organigrama de la guardia del H.I.G.A Vicente López y Planes”

*administración de Enfermería, trazabilidad de lotes, farmacovigilancia y stock*⁷. En este contexto, diversos hospitales han desarrollado estrategias orientadas a integrar los sistemas de gestión farmacéutica con la Historia de Salud Integrada (HSI), con el propósito de optimizar la prescripción, dispensación y seguimiento de medicamentos; evitando la duplicidad, reduciendo errores y facilitando decisiones basadas en datos. El análisis de estas experiencias resulta relevante para comprender los beneficios, desafíos y oportunidades asociados a la interoperabilidad de los sistemas de información de salud, aportando elementos de referencia desarrollados en el presente diagnóstico.

Tanto el Hospital Posadas como el Hospital Italiano de Buenos Aires iniciaron procesos de modernización tecnológica con el objetivo de reemplazar sistemas fragmentados y procedimientos en papel por plataformas digitales integradas.

En el caso del Hospital Posadas, la estrategia de innovación incluyó la implementación de un Sistema de Información Hospitalario, la digitalización de historias clínicas y la automatización de los servicios de farmacia. Estas iniciativas formaron parte de un proyecto más amplio de transformación digital destinado a optimizar la gestión hospitalaria y mejorar la calidad asistencial; *“permitiendo la trazabilidad total desde la llegada de los medicamentos a la farmacia hospitalaria hasta su dispensación al paciente”*⁸.

Por su parte, el Hospital Italiano desarrolló durante años una Historia Clínica Electrónica propia, sobre la cual posteriormente incorporó el proyecto de receta electrónica interoperable, incorporando diversas herramientas para una mejor atención de los pacientes y una mejora en la trazabilidad de los medicamentos. Una de esas herramientas es la implementación de *“envío de recetas por correo electrónico como canal provisorio de comunicación con los pacientes”*⁹. Cumpliendo así con las normativas nacionales que impulsan la interoperabilidad entre instituciones y farmacias.

⁷ Revista médica Ocronos, “Integración de Sistemas Informáticos en Farmacia Hospitalaria”<https://revistamedica.com/implicaciones-integracion-sistemas-informaticos-farmacia-hospitalaria/amp/>

⁸ Hospital Posadas: Automatización de Farmacias. Inhar (empresa tecnológica)<https://inhar.com.ar/hospital-posadas-automatizacion-de-farmacia/>

⁹ Hospital Italiano – Avances en el proyecto de receta electrónica interoperable
[Avances en el proyecto de receta electrónica interoperable | Hospital Italiano](#)

Esta integración entre farmacia y HSI, se llevó adelante mediante la conexión de los procesos de prescripción médica con los sistemas de dispensación y gestión farmacéutica; generando múltiples ventajas:

- Mayor seguridad del paciente al reducir errores de prescripción y dispensación.
- Trazabilidad completa del medicamento desde la indicación médica hasta su administración.
- Control más eficiente del stock farmacéutico.
- Disminución del uso de documentación en papel.
- Optimización de tiempos de trabajo para médicos, farmacéuticos y personal de enfermería.
- Disponibilidad de información en tiempo real para la toma de decisiones clínicas y administrativas.

La unificación del sistema de farmacia con la Historia de Salud Integrada (HSI) constituye un paso fundamental en la transformación digital de las instituciones sanitarias. Tanto el Hospital Posadas como el Hospital Italiano han desarrollado estrategias diferentes pero complementarias: mientras el primero avanzó en la automatización física y logística de la farmacia, el segundo fortaleció la interoperabilidad de la prescripción electrónica dentro de su historia clínica digital. En ambos casos, el objetivo común fue mejorar la seguridad, la trazabilidad y la calidad de la atención brindada a los pacientes.

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Nuestro diagnóstico de situación, el cual realizamos en el Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A.) “Vicente López y Planes”, tuvo como eje central el concepto de análisis sobre **cuatro dimensiones**:



Fuente: Elaboración propia, a partir de la experiencia de práctica situada en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez (2026).

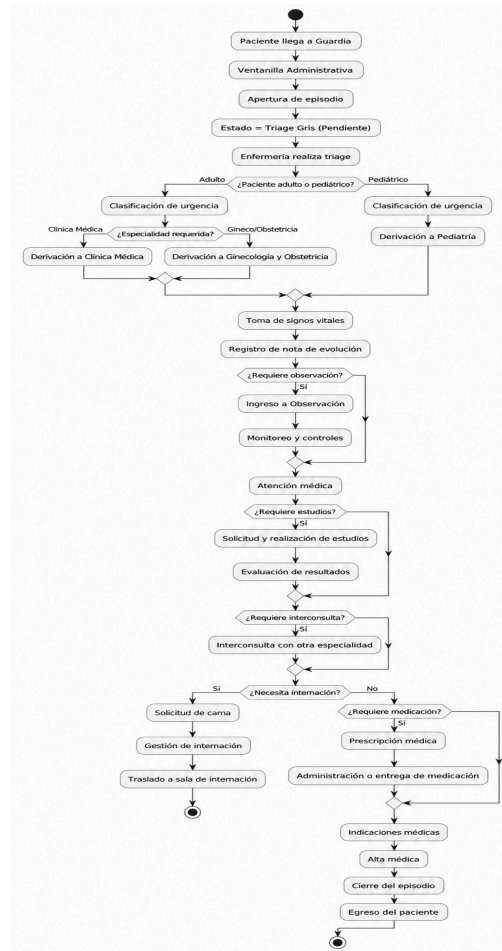
Esto nos devuelve una perspectiva sistémica y circular porque se retroalimentan constantemente, por ello analizando el contexto institucional en el cual desarrollamos nuestras prácticas y la observación de la estructura hospitalaria, nos permitió identificar cómo estaba organizado el servicio de Emergencia (Guardia) y los recursos disponibles para la atención de la población. Al mismo tiempo, nuestro estudio nos permitió realizar el circuito de atención, pudiendo diseñar el recorrido que realizan los pacientes desde su ingreso al establecimiento por guardia, hasta la resolución de sus necesidades de salud.

Para comprender este cambio, se analizaron los sistemas de información que se utilizaban antes de la implementación del HSI y los que se están utilizando actualmente¹⁰.

¹⁰ Véase Anexo I: “Registro fotográfico de la dispensación de medicamentos de farmacia”

Guardia	Antes	Actualidad
¿Cómo se organizaba/funcionaba?	Por orden de llegada, atención con el médico.	Ventanilla, triage por colores, deriva al sector correspondiente.
¿Qué problemáticas se visualizaban?	Carga historia clínica papel, estudios complementarios.	HSI, papel y drive.
¿Qué sistema de información se utilizaba?	Goldberg, Word, papel.	SIGEC, Goldberg , HSI, Drive, papel, Nobilis, PACS privado, Intranet , Red provincial de farmacia

3.1 Diagrama de Actividades “Circuito tránsito de personas en el área de Guardia”¹¹



"El circuito de atención en Guardia del Hospital Rodríguez se desarrolla a través de una serie de etapas asistenciales y administrativas que permiten garantizar la evaluación, el diagnóstico y la resolución de la demanda de atención de los pacientes que ingresan al servicio."

El circuito de atención comienza cuando el paciente ingresa al servicio de Guardia. En primer lugar, se realiza el registro administrativo y la apertura del episodio en el sistema de información. Una vez

¹¹ Véase Anexo I: Diagrama Modelado UML “Circuito de tránsito de personas en el área de Guardia”

generado el ingreso, el paciente queda en estado pendiente hasta que enfermería realiza el triage correspondiente, en donde se efectúa la toma de signos vitales (presión, saturación y temperatura) y el registro de la evolución clínica inicial. En esta instancia, se evalúa la condición de urgencia del paciente (rojo, naranja, amarillo y verde)¹², derivando al área correspondiente (adulto o pediátrica). En los pacientes adultos, según la necesidad asistencial, se deriva a Clínica Médica o al servicio de Ginecología y Obstetricia. En el caso de los pacientes pediátricos, al área de Pediatría.

Si el médico de urgencia lo requiere, el paciente ingresa al sector de observación, donde se realizan controles y monitoreo hasta ser evaluado nuevamente por el profesional médico. Durante la atención médica, el profesional determina si es necesario solicitar estudios complementarios o interconsulta con otra especialidad. En caso de requerirse, se gestionan y realizan los estudios correspondientes, cuyos resultados son posteriormente evaluados para orientar la conducta médica. Luego de la valoración integral, se define la conducta a seguir.

Si el paciente requiere internación, se inicia la solicitud de cama, se gestionan los trámites administrativos correspondientes y se realiza el traslado al sector de internación o, dependiendo de la gravedad, la derivación hacia otro establecimiento de salud.. Por el contrario, si no requiere internación, se evalúa la necesidad de tratamiento farmacológico. En los casos que corresponda, se realiza la prescripción médica y la administración o entrega de la medicación indicada (en horario matutino, se dirigen directamente al sector de Farmacia. En el horario Vespertino, se entrega en la misma guardia).

Finalmente, se brindan las indicaciones médicas correspondientes, se otorga el alta médica, se realiza el cierre del episodio en el sistema y el paciente egresa de la institución.

Como parte del proceso de recolección de información, se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores claves vinculados con los procesos asistenciales y administrativos de la guardia.

Las entrevistas¹³ tuvieron como objetivo relevar percepciones, experiencias y prácticas relacionadas con la utilización de los sistemas de información, identificar fortalezas y dificultades operativas, y comprender el funcionamiento de los procesos involucrados en la atención de los pacientes La

¹² Véase Anexo I: "Triage Hospital Interzonal General de Agudos "Vicente López y Planes"

¹³ Véase Anexo II: Entrevistas al personal de salud del Hospital

información obtenida fue utilizada como complemento de la observación directa y del análisis documental obtenidas durante las prácticas profesionales., en donde se fueron identificando la articulación entre los sectores y las funciones de cada una de las área.

En particular, observamos el área de farmacia hospitalaria y su interacción con los otros servicios, en nuestro caso, el de guardia. Por otra parte, el sistema de información nos permitió reconocer los mecanismos utilizados para el registro, la gestión y la circulación de datos relacionados con la atención de los pacientes y la administración de medicamentos e insumos. La integración de estas dimensiones posibilita construir un diagnóstico de situación que refleja las fortalezas y las oportunidades de mejora presentes en la institución, constituyendo la base para la formulación del producto situado y las propuestas de intervención orientadas a optimizar dichos procesos.

Con el propósito de sistematizar la información relevada durante las prácticas, se elaboró una matriz de Análisis de FODA, herramienta que nos permitió analizar de manera integral los factores internos y externos que influyen en el funcionamiento del servicio de Guardia. A partir de los resultados obtenidos fue posible identificar los recursos y capacidades con el cual cuenta el servicio, así como también las limitaciones y desafíos que podrían afectar la calidad de atención.

3.2 FODA



Fortalezas

La implementación de HSI en el servicio de guardia constituye una de las principales fortalezas identificadas. El sistema permite registrar digitalmente la información clínica y administrativa de los pacientes, facilitando el acceso a los datos de manera rápida y segura. Esto contribuye a mejorar la continuidad de la atención, optimizar los tiempos de respuesta y reducir la dependencia de registros en papel.

Otra fortaleza importante es la experiencia y el compromiso del personal de salud y administrativo. Durante las entrevistas realizadas se observó una buena predisposición de los equipos para adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas y participar en el proceso de transformación digital. Asimismo, la disponibilidad de información clínica digital favorece la toma de decisiones asistenciales y permite un mejor seguimiento de los pacientes dentro de la institución.

Oportunidades

La principal oportunidad identificada es la posibilidad de integrar el sistema de farmacia con HSI. Esta integración permitiría compartir información en tiempo real sobre prescripciones, stock y dispensación

de medicamentos, favoreciendo una gestión más eficiente y segura. Además, contribuiría a disminuir errores, evitar duplicación de tareas y mejorar la coordinación entre los distintos sectores involucrados en la atención del paciente.

Por otro lado, la continuidad de la implementación de HSI en todos los servicios del hospital representa una oportunidad para fortalecer la digitalización institucional. Esto permitiría automatizar reportes, mejorar la calidad de los registros, optimizar la comunicación entre sectores y generar información confiable para la gestión hospitalaria. También favorece el desarrollo del Modelo de Cuidados Progresivos mediante una mejor integración de la información clínica.

Debilidades

Entre las debilidades más relevantes se encuentra la falta de integración entre farmacia y HSI. Actualmente, la farmacia utiliza un sistema independiente, lo que dificulta el intercambio de información y obliga a realizar registros en diferentes plataformas. Esta situación genera duplicación de tareas, aumenta la carga administrativa y puede ocasionar inconsistencias en los datos.

Asimismo, se identificó la persistencia de procesos manuales y el uso de planillas o registros en papel para determinadas actividades. Esto incrementa el riesgo de errores y retrasa la disponibilidad de información. También se observó la falta de integración de sistemas entre algunos sectores del hospital, dificultando el acceso a una visión integral y actualizada de la situación clínica y administrativa de los pacientes.

Amenazas

Una de las principales amenazas es la utilización de sistemas no integrados, ya que esto genera errores en la información, duplicación de registros y dificultades en la coordinación entre sectores. La falta de integración puede impactar negativamente en la calidad de la atención y en la toma de decisiones clínicas.

Además, el aumento constante de la demanda asistencial en la guardia puede superar la capacidad operativa del servicio, especialmente cuando existen procesos administrativos complejos o recursos humanos limitados. A esto se suma la dependencia de la tecnología, ya que cualquier falla en los

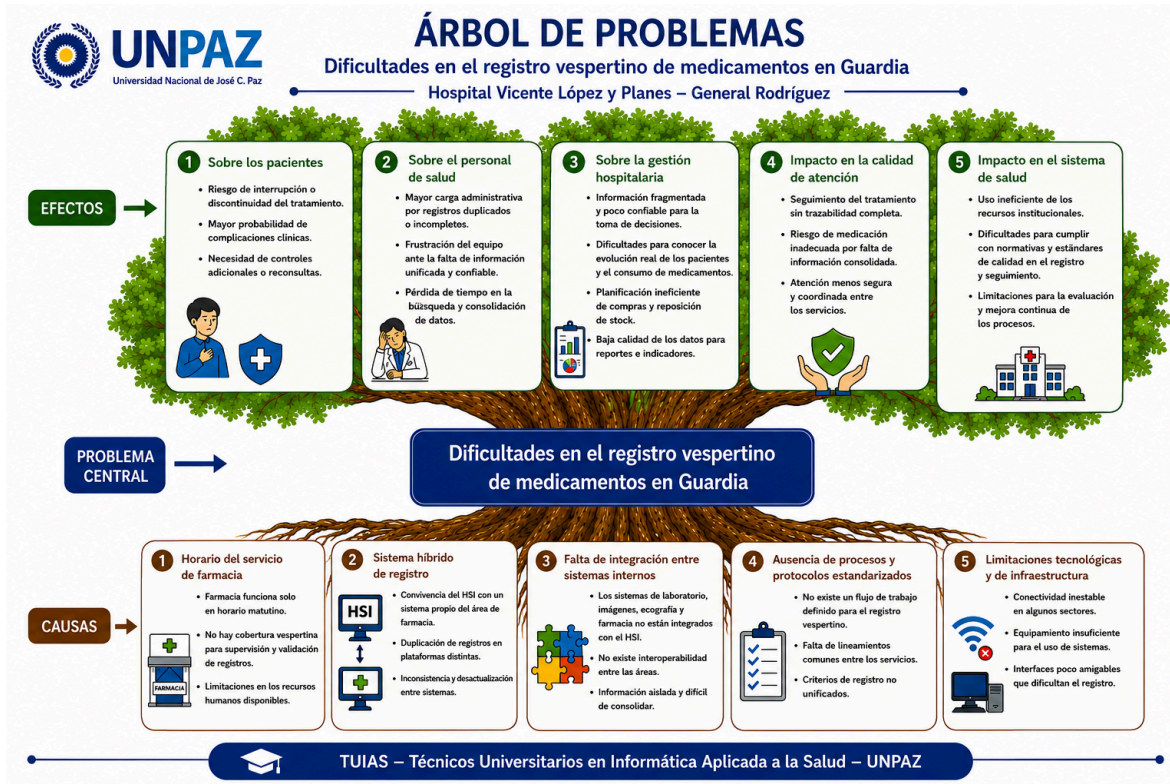
sistemas informáticos o en la conectividad puede afectar el acceso a la información y generar demoras en la atención y en el registro de la dispensación de medicamentos.

3.3 Análisis de las dificultades en el registro vespertino de medicamentos

Uno de los problemas más relevantes identificados durante el diagnóstico se relaciona con el registro de la dispensación y control de stock de medicamentos para los pacientes que se atienden en el servicio de Emergencia (guardia), en el horario vespertino. Si bien la misma brinda atención las veinticuatro horas del día, observamos que la misma no cuenta con un registro de esa dispensación directa. La guardia cuenta con un stock de la medicación e insumos que se podría utilizar durante la guardia y la cual es entregada por el servicio de farmacia al personal de enfermería. Para ello, el sector de farmacia se encarga de armar los stocks de insumos y medicamentos que se distribuirán en los diferentes sectores y subsectores del hospital.

La medicación que es entregada durante el horario vespertino, se registra de manera manual; es decir, completando una planilla con los datos del paciente (nombre, apellido, DNI, número de teléfono) y adjuntando la receta entregada por el profesional al paciente. Al siguiente día, dicha planilla es entregada al sector de farmacia para que la misma sea cargada al sistema correspondiente (Intranet) para realizar el control de los mismos.

Es precisamente en este tramo donde observamos la falta de integración entre el sistema que utiliza el servicio de Farmacia y el HSI, generando así una brecha operativa; dificultando el registro y estoqueo de medicamentos e insumos directamente en el sistema. Al mismo tiempo, también se observó que las limitaciones de índole presupuestarias dificultan la incorporación de recursos humanos que permitan extender la atención en el servicio de farmacia.



4. CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado permite concluir que el Hospital Interzonal General de Agudos (H.I.G.A) “Vicente López y Planes” ha logrado avances significativos en el proceso de la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI); evidenciando el compromiso de la gestión institucional con la mejora continua de los procesos asistenciales y administrativos. La conducción del hospital ha demostrado voluntad política y capacidad organizativa para sostener la atención de una población con alta demanda sanitaria, impulsando la incorporación progresiva de herramientas digitales y adaptando los procesos de trabajo a las posibilidades y recursos disponibles.

En este contexto, la implementación de la HSI en el área ambulatoria de guardia representa un avance relevante hacia la digitalización de los registros clínicos y la mejora de la continuidad de la atención. Asimismo, se observó un importante esfuerzo de los equipos de trabajo para garantizar el

funcionamiento de los servicios, aun frente a limitaciones de infraestructura, recursos humanos y disponibilidad tecnológica.

No obstante, el análisis efectuado permitió identificar desafíos vinculados con la articulación entre los sistemas de información, los circuitos de trabajo y la gestión de medicamentos en el ámbito de la guardia. Estas situaciones no deben interpretarse como problemáticas exclusivas de la institución, sino como manifestaciones de limitaciones estructurales y organizacionales presentes en gran parte del sistema público de salud. Asimismo, ponen de manifiesto la distancia que puede existir entre los lineamientos normativos y las condiciones reales en las que se desarrollan las prácticas cotidianas. En pocas palabras, son las políticas públicas quienes no contemplan los lineamientos en el cual el Manual de Cuidados Progresivos debe ejecutarse y que el centro de salud cuente con el personal suficiente con el cual debería contar cada uno de los turnos, ni los escenarios de conectividad ausente o intermitente y las condiciones reales de la institución.

El estudio del circuito de trabajo permitió comprender la dinámica de interacción entre los distintos integrantes del equipo de salud, así como el papel que desempeñan los sistemas de información en el registro, la circulación y la gestión de los datos vinculados con la atención de los pacientes. En particular, el análisis de la relación entre el servicio de guardia y el área de farmacia aportó elementos relevantes para comprender los procesos involucrados en la dispensación y el seguimiento de medicamentos.

La integración del análisis organizacional, funcional e informático posibilitó construir un diagnóstico de situación que refleja tanto las fortalezas institucionales como los aspectos susceptibles de revisión. De este modo, el trabajo realizado constituye una base sólida para la comprensión de la realidad institucional y para el desarrollo de futuras propuestas orientadas al fortalecimiento de los procesos asistenciales y de gestión, en concordancia con las necesidades.

Las dificultades observadas no responden a una falta de compromiso institucional, sino a limitaciones estructurales, presupuestarias y organizacionales que afectan a gran parte de los hospitales públicos del país. En este contexto, resulta necesario diseñar nuevas estrategias que permitan optimizar los recursos disponibles y mejorar progresivamente los procesos de atención.

5. ANEXO I

Triage Hospital Interzonal General de Agudos “Vicente López y

Planes” https://drive.google.com/file/d/1H0-gRBM8SyqRTqAm505FqVgRSh_50F/view?usp=drive_link

Cuadro de los niveles de Triage, dependiendo el cuadro de urgencia

https://drive.google.com/file/d/1qHzfRf3r_qfoZbXwSSsraF_BuRYFqji7/view?usp=drive_link

Organigrama de la guardia del H.I.G.A Vicente López y Planes:

<https://canva.link/ca8a29g9wzhe4tt>

Diagrama Modelado UML “Circuito de tránsito de personas en el área de Guardia”

https://www.planttext.com/?utm_source

Registro fotográfico de la dispensación de medicamentos en farmacia

https://docs.google.com/document/d/1yIo__40oq4Y7Bi9qods0Qmg3S_mIt5EQBCYjHRLl4RY/edit?usp=drive_link

Registro fotográfico del servicio de guardia y los procesos observados durante la práctica situada.

https://docs.google.com/document/d/1H_FLiF_QlSat76bpkfZVI6pgMuw5CkhXSF047-2qmQU/edit?usp=drive_link

5.1 ANEXO II

Entrevistas

Entrevista a Cecilia Rubio - Licenciada en Trabajo Social y Directora asociada al hospital. Fecha: Jueves 7 de mayo del 2026. Tipo de entrevista: De caso.

https://docs.google.com/document/d/1lO1fumBkpZgEyBs0v_rw9LKXAv34zQfAhyVS7nvFuqs/edit?usp=drive_link

Entrevista al Dr. Juan Asselborn - Jefe de guardia de emergencias. Fecha: Jueves 14 de mayo del 2026. Tipo de entrevista: De caso.

https://docs.google.com/document/d/1JlJug7cqEVWmuDrrBhhkeOiK6ez0AAvqiULU0y0wwU0/edit?usp=drive_link

Entrevista a Jesica Coria - Coordinadora administrativa de guardia. Fecha: Jueves 14 de mayo del 2026. Tipo de entrevista: De caso.

https://docs.google.com/document/d/1Ue-NrCpDcJIs68sr4JptlCTlRk7SeO9t1q-zrcGeO_Y/edit?usp=drive_link

Entrevista a Joaquín Carabajal - Implementación de HSI. Fecha: Jueves 21 de mayo del 2026. Tipo de entrevista: De caso y Fecha: 4 de junio del 2026. Tipo de entrevista: Semiestructurada.

https://docs.google.com/document/d/1vVWBR-zoTkdaJNX0dQK4EUsw3vCD8lRyYfVl57pEcsg/edit?usp=drive_link

Entrevista a Myrian Villani - Jefa de servicio de farmacia y a Victoria Anghileri- Secretaria. Fecha: 4 de junio del 2026. Tipo de entrevista: De caso.

https://docs.google.com/document/d/1xiqh_RMamSzxEsJSIYPk6LbQvq_NDtT4bzD5K3J6SE8/edit?usp=drive_link

6. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Salud de la Nación.(2023). *Resumen Ejecutivo: Plan Quinquenal de Salud*.

<https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/wp-content/uploads/sites/244/2023/04/Resumen-Ejecutivo-Plan-Quinquenal-de-Salud.pdf>

Ministerio de Salud de la Nación.(Noviembre 2025). *Manual de Funciones y Procesos para la Implementación de los Cuidados Progresivos en Hospitales Bonaerenses*.

<https://nc.ms.gba.gov.ar/index.php/s/9CC32jcwW9gJyN3>

Ministerio de Salud de la Nación. Programa REMEDIAR: ¿Qué es REMEDIAR? [Argentina.gob.ar](https://www.argentina.gob.ar).

<https://www.argentina.gob.ar/salud/remediar/que-es-remediar>

Hospital Interzonal General de Agudos "Vicente López y Planes". (s.f.). *Reseña Institucional e Historia*.

Ministerio de Salud de la Nación. <https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hvicentelopezplanes/institucional/historia/>

Revista médica Ocronos, “Integración de Sistemas Informáticos en Farmacia

Hospitalaria”<https://revistamedica.com/implicaciones-integracion-sistemas-informaticos-farmacia-hospitalaria/amp/>

Hospital Posadas: Automatización de Farmacias. Inhar (empresa

tecnológica)<https://inhar.com.ar/hospital-posadas-automatizacion-de-farmacia/>

Hospital Italiano – Avances en el proyecto de receta electrónica interoperable

[Avances en el proyecto de receta electrónica interoperable | Hospital Italiano](#)

Hospital Posadas: Innovación (videos)

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/automatizacion-de-la-farmacia-hospitalaria>